

Fecha Última Actualización: 03-04-2022 8:26:16

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Fredy Ramon Gutierrez Sepulveda
Edad : 60a 1m 22d
Dirección : Los Panderos 1130

Rut : 8.928.070-2
Fecha Nacto: 12/02/1962
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1403269
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5959 1637

N° Epicrisis
301802

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 29/03/2022 19:03

Días Estadía: 5

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 03/04/2022 08:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

COMPROMISO DE CONCIENCIA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

NOMBRE: FREDY RAMON GUTIERREZ SEPULVEDA.
EDAD: 60 AÑOS.
FECHA INGRESO URGENCIAS: 29/03/22
FI A UTAC: 29/3/22
FI A RECUPERACIÓN: 30/3/22
FI A UCI: 31-03-22

· ANTECEDENTES MÓRBIDOS: NO REFIERE, NO SE CONTROLA
· ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS: FRACTURA DE PELVIS (2013)
· ANT. FAMILIARES: PADRE DM
· ALERGIAS (-)
· MEDICAMENTOS DE USO HABITUAL: NO
· HÁBITOS: TBQ ACTIVO DESDE ADOLESCENCIA 15 CIG/DIA. OH NO REFERIDO DROGAS NO REFERIDO
· OCUPACION: JARDINERIA
· VIVE CON SU HERMANA HACE 6 MESES - CLAUDINA

MOTIVO CONSULTA: COMPROMISO DE CONCIENCIA

CUADRO ACTUAL: (SEGÚN FICHA CLÍNICA, YA QUE NO CUENTO CON FAMILIARES)

A LAS 12:30 DEL DIA 29/03 EL PACIENTE INICIO DE FORMA SUBITA CUADRO DE DESVIACIÓN DE COMISURA LABIAL, DESCONEXION CON EL MEDIO E IMPOSIBILIDAD PARA CAMINAR. POR LO ANTERIOR CONSULTARON AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HPH. INGRESO A LAS 13:14 HRS., CON NIHSS 30 (2-2-2-2-2/1-4-2-4-2/0-3-3-2-0) SE REALIZÓ TC DE ENCEFALO + ANGIOTC EL QUE IMPRESIONO PRESENCIA DE ACV ISQUEMICO M1 IZQUIERDA. ASPECT 10. SE INICIÓ A LAS 13:49 HRS. TENECTEPLASE 25 MG EV EN BOLO. NIHSS A LAS 15 MIN: 28. EVOLUCIONÓ CON TENDENCIA A LA HIPERTENSION (183/119), REQUIRIENDO BOLOS Y POSTERIORMENTE BIC DE LABETALOL. SE PRESENTA CASO A NEURÓLOGO DE TURNO DEL HSR PARA GESTIONAR TROMBECTOMIA. INGRESO AL SERVICIO DE URGENCIA DEL HSR A LAS 17:47 HRS. AFEBRIL (36.3°), NORMOTENSO (123/68), NORMOCARDICO (82X'). NIHSS 27. SE REALIZÓ RM DE ENCEFALO A LAS 17:52 HRS. EL QUE MOSTRÓ OBSTRUCCION DE M1 DISTAL DE ACM IZQUIERDA, CON CONSOLIDACION DEL INFARTO Y SIGNOS DE MICROHEMORRAGIAS. POR LO ANTERIOR ES QUE NO SE OPTÓ POR TROMBECTOMÍA.

Fecha Epicrisis : 03/04/2022 08:26

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 03-04-2022 8:26:16

Página 2 de 4

EVOLUCIONÓ CON EPISODIO FEBRIL Y POR PRESENCIA DE SOPLO SISTOLICO SE SOSPECHÓ CUADRO DE ENDOCARDITIS, POR LO QUE SE TOMAN HEMOCULTIVOS Y SE INICIÓ TRATAMIENTO ANTIBIOTICO. SE REALIZÓ ECOGRAFIA TRANSTORACICA EN URGENCIAS EL QUE SE DESCRIBE PRESENCIA DE MASA HIPERECOGENICA EN VENTRICULO IZQUIERDO.

SE INDICA TRASLADO A UTAC (SIN EMBARGO POR AUSENCIA DE CAMAS SE MANTIENE EN URGENCIAS) POR CUADRO DE INFARTO EXTENSO DE ACM IZQUIERDA CON SOSPECHA DE ENDOCARDITIS.

PACIENTE EVOLUCIONA EN REGULARES CONDICIONES, HOY PRESENTA MAYOR COMPROMISO DE CONCIENCIA POR LO QUE ES EVALUADO POR NEUROLOGO DE TURNO (DR. LÓPEZ) QUIEN ENCUENTRA A PACIENTE EN SOPOR PROFUNDO. SIN EMISIÓN DE LENGUAJE. ANISOCORIA CON MIDRIASIS IZQUIERDA. PFC DERECHA, CAÍDA DE CORNEAL A DERECHA. HEMIPLEJIA BC DERECHA EN POSTURA DE DESCEREBRACIÓN. SE SOLICITA TC DE URGENCIA QUE EVIDENCIA COMPORTAMIENTO MALIGNO DE INFARTO CEREBRAL CON HERNIACIÓN UNCAL Y SUBFALCINA. SE DA AVISO A NEUROCIRUGÍA PARA CRANIECTOMÍA DESCOMPRESIVA DE URGENCIA.

SE REALIZA CRANIOTOMIA FRONTOTEMPOROPARIETAL IZQUIERDA SIN INCIDENTES. DURANTE EL PROCEDIMIENTO PACIENTE ES APOYADO CON NAD A DOSIS BAJAS PARA MANTENER PAM 70 MMHG. HEMODINAMIA SIEMPRE ESTABLE. SE CARGA CON FENITOÍNA. SE VOLEMIZA CON 2000 CC DE RL, SIN REQUERIMIENTOS TRANSFUSIONALES.

PACIENTE INGRESA A RECUPERACIÓN HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, PAM 80 MMHG SIN APOYO VASOACTIVO. BUENA PERFUSIÓN CLÍNICA. EN SAS 1 SE SEDA CON FENTANYL + MIDAZOLAM. PUPILAS MIOTICAS ISOCORICAS REACTIVAS A LA LUZ. PULMONAR EXAMEN LIMPIO. RR2T, SOPLO SISTÓLICO DE FOCO AORTICO II/VI. ABDOMEN EXCAVADO, ABULTADO POR DEPOSITO DE CALOTA EN CAVIDAD ABDOMINAL, APOSITO LIMPIO Y SECO. RHA +. EXTREMIDADES ENFLAQUECIDAS, PULSOS DISTALES +. TIBIO A DISTAL.

SE TRASLADA A UCI PARA CONTINUAR MANEJO.

EXAMEN FISICO DE INGRESO:

FC: 81 LPM/ PA: 116 /68 MMHG / PAM: 79 MMHG/ FR: 22 RPM/ T°: 36.6 °C/ SATO2: 100 % / FIO2: 30 %
CON SEDOANALGESIA. SAS 1. PUPILAS ISOCÓRICAS, MIÓTICAS. SIN MAYOR REACTIVIDAD A LOS ESTIMULOS.
LLENE CAPILAR 2 SEG, TIBIO A DISTAL, MOTTILING (0). CON REGULAR HIDRATACIÓN EN MUCOSAS.
CABEZA Y CUELLO: NORMOCRANEO (SIN CALOTA A IZQUIERDA. PUPILAS ISOCORICAS. YUGULARES NO INGURGITADAS.
CORAZÓN: RR 2T. CON SOPLO SISTÓLICO
PULMONAR: MP (+). RESTO SIN MAYORES CAMBIOS.
ABD: BDI, RHA (+). SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL: (-)
EES: EDEMA (-). SIGNOS DE FLEBITIS (-).
EEII: EDEMA (-). SIGNOS DE TVP (-).
NEUROLÓGICO: LO COMENTADO, RESTO NO EVALUADO.
ECOSCOPIA: NO REALIZADA.

DIAGNOSTICOS

- 1.- INFARTO ISQUEMICO DE TERRITORIO DE ACM IZQUIERROBSTRUCCIÓN DE ACM IZQUIERDA M1 DISTAL
- 2.- INFARTO ISQUEMICO PARIETAL DE TERRITORIO DE ACA IZQUIERDA
- OBS ENDOCARDITIS BACTERIANA
3. -PO CRANEOTOMÍA DESCOMPRESIVA FTP IZQUIERDA

EVOLUCION

INGRESA GRAVE EN MALAS CONDICIONES GENERALES. HDN INESTABLE CON ALTOS REQUERIMIENTOS DE DVA, CONECTAOD A VMI SIN ALTERACIONES DE INTERCAMBIO.AFEBRIL PERO CON PARAMETROS INFLAMATORIOS AL ALZA SIN TTO ATB.,

TAC DE CONTROL DEL 01.04.2022 MUESTRA MAYOR EXPANSION DE EDEMA CEREBRAL CON SIGNOS DE INFARTO CONTRALATERAL Y HERNIA SUBFALCINA. ¿ EVALUADO POR NEUROLOGIA SE INDICA MANTENER SEDACION.

Fecha Epicrisis : 03/04/2022 08:26

Página 2 de 4

EL 02.04.2022 SE CONTACTO A NX DE TURNO ¿ DR GARCIA, CON QUIEN SE ACUERDA MEDIDAS ANTIEDEMA ¿ SEDACION PROFUNDA Y RECONTROL CON TAC.

HDN: INESTABLE CON NA HASTA 0.85UG/KG/MIN PARA MANTENER PPC > 65 (PAM 80-85), VEC CONTRAIDO, SE REPONE CON SF EN BOLOS ¿ VT 3000 CC. ¿ CORRECCION CALCEMIA E HIPOALBUMINEMIA. CON DESCENSO DE LOS PARAMETROS HASTA NA 0.5UG/KG/MIN. POR LA MADRUGADA COMIENZA CON NUEVOS AUMENTOS DE REQUERIMIENTOS POR LO QUE SE ASOCIA EPINEFRINA, CON ALZAS PROGRESIVAS, SIN RESPUESTA CLINICA.

VENTILATORIO: CONECTADO A VMI EN V/AC CON NORMOCAPNIA¿ SE AUMENTA PEEP A 8 DEJANDO VT A 7ML/KG, ASI COMO FIO2 0.5 LEVE HIPOXEMIA (CONSIDERAR SAT DE O2 ENCEFALICO)

INFECCIOSO: AFEBRIL PERO CON ASCENSO IMPORTANTE DE LOS PARAMETROS INFLAMATORIOS, CULTIVOS TOMADOS PENDIENTES. -> INICIO AMPICILINA/SULBACTAM HASTA CONTROL DE EXAMENES.

RENAL: ANURICO CON DIURESIS ESCASA ¿ ELEVACION DE LOS PARAMETROS NITROGENADOS CON HIPERFOSFEMIA Y ACIDOSIS METABOLICA IMPORTANTE PH 7.2 EB -12 BIC 12. QUE SE CORRIGE CON BIC 2/3 MOLAR. ¿ ADICIONO GLUCONATO DE CALCIO EV POR HOY ¿ MAÑANA CARBONATO ¿ BIC ENTERAL. SEROLOGIA ACTUALIZADA. HOY EVALUADA POR DR GUERRA ¿ SE DECARTA TRR AYER. ¿ EVALUACION DIARIA.

NEUROLOGICO/NX : SE ACOMODA CABEZA A LINEA MEDIA ESTRICTA ¿ CAMBIO FNT EV POR LEVETIRACETAM (NO SE DISPONE DE FNT EN LA INSTITUCION) ¿ EN RELACION A EDEMA SEVERO PROGRESIVO ¿ SE INICIA SSH 10% EN BOLOS 60ML/8HORAS POR 3 DIAS. ¿ CONTROL CON NATREMIA CADA 8 HORAS.

HEPATICO: ELEVACION DE LAS PRUEBAS HEPATICAS ¿ TINTE ICTERICO ¿ CON ALTERACION DE P DE

COAGULACION. -> SE INICIA KONAKION POR 3 DIAS.

NUTRICIONAL: REGIMEN CERO CON SNG A CAIDA LIBRE (POR SHOCK PROFUNDO) ¿ HGT CON TENDENCIA A LA HIPOGLICEMIA. ¿ CONTROL SERIADO

DURANTE LA MADRUGADA, PRESENTA REQUERIMIENTOS MAYORES DE DVA, CON REDUCCION DE FRECUENCIA CARDIACA, Y MAYORES REQUERIMIENTOS DE O2, SIN RESPUESTA A VOLUMEN. SIN EXPOSICION DE SANGRADO NI OTRA CONDICIONANTE CLINICA. ¿ IMPRESIONANDO CON ENCLAVAMIENTO.

A LAS 07:50 PRESENTA PCR EN ASISTOLIA
SE CONSTATA FALLECIMIENTO DEL PACIENTE CITADO

INTENTO CONTACTO TELEFONICO CONFAMILIAR, SIN ÉXITO.
PENDIENTE ENTREGA DE CERTIFICADO DE DEFUNCION CONTRA CARNET

Diagnóstico de Egreso

Accidente vascular isquémico - ACV ISQUEMICO IZQUIERDO MALIGNO

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIMIENTO

Plan Post Alta

ENTREGA CERTIFICADO DE DEFUNCION

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 03/04/2022 08:26



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 03-04-2022 8:26:16

Página 4 de 4

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Eduardo Cisternas Fuentes
Médico Tratante (Staff)